

TEXTOS PUBLICADOS EM 1995

- 109 - *Democratização e Controle na Saúde: Análise do Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro.*
de Roseni Pinheiro e Mario Roberto Dal Poz
- 110 - *Por Um Contraponto Teórico-metodológico entre o Planejamento Estratégico-situacional (PES) e o Controle de Qualidade Total (T.Q.C.) na Saúde Pública.*
de Francisco Javier Uribe Rivera
- 111 - *A Prescrição Médica.*
de Vera Lúcia Edais Pepe e Cláudia Maria Travassos Veras
- 112 - *Espelho Espanhol de FHC.*
de José Luís Fiori
- 113 - *Por Que Governabilidade? Qual Governabilidade?*
de José Luís Fiori
- 114 - *Arquivo Rockefeller: Banco de Dados.*
de Luiz Antonio de Castro Santos e Lina Rodrigues de Faria
- 115 - *O Federalismo Frente ao Desafio da Globalização.*
de José Luís Fiori
- 116 - *Social Liberalismo: A Bússola Quebrada de Fernando Henrique Cardoso.*
de José Luís Fiori
- 117 - *Estado do Bem-Estar Social: Padrões e Crises.*
de José Luís Fiori
- 118 - *Modelos de Intervenção do Estado na Área da Saúde.*
de Ana Luiza Vianna
- 119 - *O Modelo de Assistência Médica de Pedro Ernesto (1932): Algumas Considerações.*
de André de Faria Pereira Neto
- 120 - *A Governabilidade Democrática na Nova Ordem Econômica.*
de José Luís Fiori
- 121 - *Perfil de Morbidade em um Ambulatório Médico Bancário no Ano de 1994.*
de Tula Maria Silva Moreira
- 122 - *A História da Profissão Médica: Algumas Considerações.*
de André de Faria Pereira Neto
- 123 - *Dependência Tecnológica: Uma Proposta de Interpretação.*
de Cid Manso de Mello Vianna
- 124 - *A Dinâmica dos Conselhos Municipais de Saúde no Estado do Rio de Janeiro: Três Estudos de Casos.*
Angra dos Reis, Resende e Bom Jesus do Itabapoana.
de Roseni Pinheiro
- 125 - *Conceito Objetivo, Denominação Extrínseca e Entia Rationis em Francisco Suarez (1548-1617).*
de André Rangel Rios
- 126 - *A Pesquisa no Brasil: Organização (parte I).*
de Reinaldo Guimarães (et al)
- 127 - *A Pesquisa no Brasil: Desempenho (parte I).*
de Reinaldo Guimarães (et al)
- 128 - *Tulpas, Moedas e Reformas: Que Horas São?*
de José Luís Fiori
- 129 - *Terapêutica e Mito.*
de Jane Dutra Sayd
- 130 - *Indústria Farmacêutica: Uma Análise da Estrutura e Evolução Industrial.*
de Cid Manso de Mello Vianna
- 131 - *Figurações Freudianas do Feminino.*
de Silvia Alexim Nunes
- 132 - *O Brasil e a Índia no Cenário Político Internacional dos Próximos Anos.*
de José Luís Fiori
- 133 - *A Indústria de Equipamentos Médicos: Uma Análise da Evolução e Estrutura de Mercado.*
de Cid Manso de Mello Vianna

TEXTOS PUBLICADOS EM 1996

- 134 - *Leitura Psicanalítica da Perversão Social: Abordagens Atuais.*
de Carlos Augusto Peixoto Junior
- 135 - *Sobre o Trabalho de Arrighi: O Longo Século XX em Foco.*
edição de George Kornis
- 136 - *V Seminário do Projeto Racionalidades Médicas.*
coordenação de Madel T. Luz
- 137 - *Aos Condenados da Terra, o Equilíbrio Fiscal, Neoliberalismo e Políticas Públicas.*
de José Luís Fiori
- 138 - *A Psicologia Médica e as Instituições de Saúde no Brasil.*
de Gustavo Corrêa Matta
- 139 - *A Construção da Pobreza como Objeto de Política Pública.*
de Jane Souto de Oliveira

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ

INSTITUTO
DE
MEDICINA
SOCIAL

Série: Estudos em Saúde Coletiva n° 140

VI SEMINÁRIO DO PROJETO
RACIONALIDADES MÉDICAS
Madel T. Luz
Novembro 1996

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Reitor

Antonio Celso Alves Pereira

Vice-Reitora

Nilcéa Freire

Diretor do Instituto de Medicina Social

Ricardo Antonio Wanderley Tavares

Vice-Diretor do Instituto de Medicina Social

Mário Roberto Dal Poz

Série: ESTUDOS EM SAÚDE COLETIVA

ISSN 1413-7909

É uma publicação de textos para discussão do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, de exclusiva responsabilidade dos autores.

Editor

George E. M. Kornis

Produtora Executiva

Sônia Faerstein

Assistente Editorial

Victor Manoel Moreira Gonzalez

Copidesque e Revisão

Ana Silvia Gesteira

Conselho Editorial

Cid Manso de Mello Vianna / Depto. de Planejamento e Administração em Saúde
Luiz Antônio de Castro Santos / Depto. de Políticas e Instituições de Saúde
Rosely Sichieri / Depto. de Epidemiologia

Envio de Artigos, Vendas e Permutas

Série: ESTUDOS EM SAÚDE COLETIVA

Instituto de Medicina Social - UERJ

Rua São Francisco Xavier, 524 - 7º andar - bl. D
Maracanã - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.559-900

Tel.: (021) 587-7303 / 587-7572 / 284-8249

Fax.: (021) 264-1142

E-Mail: serieims@vmesa.uerj.br

Impressão e Acabamento

Gráfica da UERJ



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL

IMS INSTITUTO
DE MEDICINA
SOCIAL

ISSN 1413-7909

SÉRIE: ESTUDOS EM SAÚDE COLETIVA

VI SEMINÁRIO DO PROJETO RACIONALIDADES MÉDICAS

MADEL T. LUZ
Novembro/1996

Nº 140

VI SEMINÁRIO DO PROJETO RACIONALIDADES MÉDICAS

ESTUDO COMPARATIVO DAS MEDICINAS OCIDENTAL CONTEMPORÂNEA, HOMEOPÁTICA, TRADICIONAL CHINESA E AYURVÉDICA EM PROGRAMAS PÚBLICOS DE SAÚDE

Madel T. Luz*

Resumo - Este artigo apresenta, resumidamente, os avanços conceituais e metodológicos do projeto, desenvolvidos a partir do Terceiro Seminário do Projeto Racionalidades Médicas, em 1993, e os principais resultados do trabalho de campo (entrevistas, observações etnográficas) desenvolvidos nos últimos dois anos, relativos a três sistemas terapêuticos atuando nos serviços médicos municipais estudados no Rio de Janeiro. Esses resultados envolvem concepções e representações sociais de terapeutas e pacientes desses serviços concernentes a saúde, doença, cura, corpo, medicina, etc.

Introdução

Este artigo pretende apresentar, resumida e abrangentemente, os avanços do projeto "Racionalidades Médicas" obtidos até o presente, no seu percurso de cinco anos, no Instituto de Medicina Social da UERJ, divididos em duas fases. A primeira (1991 - 1994) foi uma fase teórico-comparativa de quatro sistemas médicos complexos (Medicina Ocidental Contemporânea, ou Biomedicina, Medicina Homeopática, Medicina Tradicional Chinesa e Medicina Ayurvédica), de acordo com uma conceituação ideal típica da categoria de

* Professora Titular do Departamento de Planejamento e Administração de Saúde do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo.

CATALOGAÇÃO NA FONTE UERJ/SISBI/SERPROT

- S485 Luz, Madel T.
Estudo comparativo das medicinas ocidental contemporânea, homeopática, tradicional chinesa e ayurvédica em programas públicos de saúde / Madel T. Luz. - Rio de Janeiro : UERJ, IMS, 1996.
47 p. - (Série estudos em saúde coletiva ; n. 140)
- Trabalho apresentado no VI Seminário do Projeto Racionalidades Médicas.
Bibliografia : p. 41-47.
ISSN 1413-7909
1. Medicina alternativa. I. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Instituto de Medicina Social. II. Título. III. Série.

CDU 616-058

racionalidade médica. A segunda fase, em desenvolvimento desde 1995, é a de pesquisa empírica, de "campo" sócio-antropológico, envolvendo entrevistas com médicos ou terapeutas não médicos, pacientes e gerentes de programas em 9 (nove) serviços de saúde estatais ou filantrópicos no município do Rio de Janeiro. Na segunda fase do projeto a medicina ayurvédica não pôde ser incluída no estudo, pelo fato de não haver no município do Rio de Janeiro nenhum ambulatório público com atividades de ayurveda. Durante o desenvolvimento do protocolo foi realizada uma série de cinco Seminários, em média anuais, onde os resultados parciais eram relatados e discutidos pela equipe pluridisciplinar do projeto com outros pesquisadores e estudantes interessados no tema, através de exposições de relatórios destinados a se tornarem posteriormente artigos¹ e finalmente, terminado o projeto, um livro sobre a comparatividade possível de distintas racionalidades médicas, bem como sua avaliação em serviços de atenção médica.

O presente trabalho retoma e reúne essa produção, em primeiro lugar, com o prévio esclarecimento de sua categoria central, que é a de racionalidade médica. Trata-se de um conceito duplamente inspirado em Max Weber: do ponto de vista teórico, ou nocional, isto é, de seu conteúdo em termos significativos, e do ponto de vista metodológico, isto é, de sua construção. Começamos pela construção do conceito, que é o ponto de vista menos complexo, para em seguida tratarmos do aspecto propriamente teórico-substantivo.

¹ Os principais artigos editados são os seguintes: LUZ, M.T.; "Racionalidades Médicas e Terapêuticas Alternativas": *Cadernos de Sociologia*, v. 7, Programa de Pós-Grad. em Sociologia, U.F.R.S., Porto Alegre, dez. 1995, p. 108-128; CAMARGO, K.R.; "A Medicina Ocidental Contemporânea, idem, p. 129-150; LUZ, H.S.; "Homeopatia e Racionalidade Médica", *Revista da Associação Paulista de Homeopatia (APH)*, SP, V. 60, nºs 3 e 4, p. 3-13, 1995; LUZ, D. "A Medicina Tradicional Chinesa (MTC)": *Série Estudos em Saúde Coletiva*, IMS/UERJ/CEPESC, n. 72, dez. 1993.

Racionalidade Médica e Racionalidades Médicas

A categoria "racionalidade médica" tem seus traços ou dimensões fundamentais modelados a partir de uma operação indutiva. Tal operação constata num objeto específico de categorização a presença, com maior ou menor grau de explicitação e clareza, daqueles traços ou dimensões fundamentais. Esta presença é condição *sine qua non* para incluir tal ou qual fenômeno, ou conjunto de fenômenos, na categoria indicada. Diferentemente do conceito clássico, definido *a priori* e analiticamente, o tipo ideal constrói-se em grande parte *a posteriori* e historicamente. A ressalva "em grande parte" visa a salientar que as dimensões dos conceitos assim construídos devem ser estabelecidas em termos de modelos ideais, o que supõe de certa forma uma operação apriorística. De qualquer modo, cabe lembrar que o tipo ideal é sempre visto, em Max Weber, como um modelo tendencial histórico, que nunca chega a se realizar de forma acabada, pois tem a capacidade de ser modificado historicamente pela ação dos atores sociais. Cremos que a explicitação mais acabada do **tipo ideal** se encontra na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo (sobretudo Introdução e Capítulo I). Esta forma de visão tendencialista do conceito, enraizada na história, elimina, a nosso ver, os efeitos apriorísticos da definição em termos de modelo ideal.

Ao estabelecermos como condição necessária e suficiente para estarmos em presença de uma racionalidade médica a existência de cinco dimensões fundamentais (morfologia, dinâmica vital, doutrina médica, sistema de diagnose e sistema de intervenção terapêutica), sabíamos que estávamos optando pelo estudo comparativo de sistemas médicos altamente complexos, e eliminando de nosso estudo uma série de práticas conhecidas como "terapêuticas alternativas". Assumíamos também que essas dimensões seriam a base de comparação entre as diversas racionalidades a serem pesquisadas.

Seriam, portanto, o signo de sua comensurabilidade. Já há, aí, nessa operação metodológica, escolhas teóricas prévias ao próprio conteúdo do conceito, que demarcam de algum modo os limites deste conteúdo.

Essa dupla operação metodológica, entretanto, nos deixou mais à vontade para estabelecermos os limites do significado teórico da categoria "racionalidade" médica. É racionalidade médica, segundo nosso projeto, todo construto lógico e empiricamente estruturado das cinco dimensões mencionadas, tendendo a constituir-se ou pretendendo constituir-se em sistema de proposições "verdadeiras" (verificáveis de acordo com os procedimentos da racionalidade científica) e de intervenções eficazes face ao adoecimento humano. Aqui não há uma tomada de posição quanto ao valor ético ou epistemológico de quaisquer dos sistemas definidos como "racionalidade médica".

Tais sistemas, vistos como "sistemas abertos", têm suas dimensões elaboradas teoricamente em maior ou menor grau, de acordo com a predominância desta ou daquela dimensão na racionalidade, e podem competir entre si na cultura atual, no que se chama mercado da cura ou, inversamente, cooperar, principalmente na dimensão da terapêutica, seja através de decisões institucionais, seja através de decisões dos agentes de cura de cada uma dessas racionalidades.

Todas as quatro racionalidades médicas escolhidas para nosso estudo têm suas raízes em sociedades complexas e altamente diferenciadas do ponto de vista cultural: a medicina ocidental contemporânea (ou biomedicina), a medicina homeopática, a medicina tradicional chinesa e a medicina ayurvédica. Embora isto possa em primeiro momento aparecer como um elemento complicador no plano metodológico, na verdade não o é, pois não se pretende comparar sistemas culturais diferentes, mas diferentes sistemas médicos

implicados numa mesma cultura. Tal cultura é a cultura atual, definida como pós-moderna, em grande parte mundializada, ao mesmo tempo unificada e fragmentária, homogeneizada por sistemas de divulgação e de socialização que eliminam fronteiras culturais, sintetizando e sincretizando símbolos, valores, representações e comportamentos face à saúde e à doença, à cura e ao risco de morrer, e à medicina.

Poderíamos mesmo dizer que o complicador teórico-metodológico para a pesquisa "racionalidades médicas" tende a ser esta convivência atual das diferentes racionalidades, seu sincretismo nas práticas da clientela e dos agentes de cura, médicos, paramédicos, ou praticantes instruídos por um mestre.

A tendência atual ao sincretismo das medicinas e terapêuticas em geral, através da prática tanto de terapeutas como de pacientes, coloca-se como desafio conceitual à "racionalidade médica", na medida em que o universo de significados próprio de cada racionalidade tende a dissolver suas fronteiras na convivência com as outras, e a idéia moderna de racionalidade como sistema, ou ao menos como um sistema clássico, ao estilo estrutural-funcional, não se mantém. Neste caso, é necessário acentuar o caráter tendencial da categoria de racionalidade: os sistemas médicos são, na verdade, quase-sistemas que se reestruturam constantemente no contato histórico-cultural, interagindo sem cessar com práticas e sistemas médicos diversos que se constroem, estruturam, solidificam, ou se desestruturam nas sociedades complexas atuais com um ritmo muito rápido. É preciso salientar também o caráter muitas vezes pouco coerente ou mesmo conflitivo interno às racionalidades, e das racionalidades médicas entre si, acentuado pela constante oposição entre saber e prática na medicina. Buscar nas racionalidades médicas, em que freqüentemente a arte e a ciência conflituam,

uma coerência típica do discurso matemático, ou mesmo econômico, é buscar o inexistente.

Creemos que acentuar o caráter tendencial da categoria, por outro lado, é ser fiel ao espírito *weberiano*, mais que à letra, pois Weber concebe a própria racionalização do social na moderna sociedade capitalista como uma tendência em processo, embora irreversível. Apesar da irreversibilidade do desencantamento do mundo pela razão, é preciso lembrar do limite que Weber oferece a este processo, através da Ética, quando nos propõe o conceito de valor social, raiz e origem de toda ação social (e como decorrência, de toda estrutura social) como fronteira de irredutibilidade da racionalidade.

Tal limite pode ser encontrado, também, em Marx, na Política, através da noção de interesse (noção que Habermas retomará mais tarde quando tratar das relações entre conhecimento e interesse)². Contra a busca (ou pretensão) histórica de universalidade que a modernidade propôs à cultura através da Razão (a racionalidade moderna sendo justamente a proposta de unidade ou unificação de sentidos e significados através de saberes e práticas sociais iluminadas pela ciência), esses autores nos falam dos limites que a ética e a política (através das noções de valor e interesse e seu caráter particularista) impõem ao processo.

Um novo limite é proposto ao projeto, e conseqüentemente à própria categoria de racionalidade, pela psicanálise, a partir de Freud, através do conceito de libido, da descoberta do desejo e do inconsciente como estruturas fundantes do psiquismo humano, e da irredutibilidade do desejo dos sujeitos aos processos de racionalização, cultural ou individual. Valor, interesse e desejo são conceitos que apontam para outras instâncias de radicação do agir,

do sentir e do pensar na vida e nas sociedades humanas, diferentes de razão e racionalidade.

Incluir tais instâncias e limites na definição de racionalidade médica não é uma operação fácil do ponto de vista conceitual. É necessário, em primeiro lugar, conceber a categoria como projeto ou sistema tendencial, como assinalamos acima. Em seguida, é necessário definir com clareza que toda racionalidade (mesmo a racionalidade científica) conserva sua base de valores, interesses e investimentos de desejo permeando permanentemente o conjunto de representações, concepções e teorizações que a definem como racionalidade. Essa dupla tomada de posição teórica nos deixou à vontade para lidar com a categoria de racionalidade médica, categoria em princípio "moderna", num contexto de pós-modernidade. Ou, em outras palavras, não há, do ponto de vista deste projeto, racionalidade "pura". As racionalidades médicas, embora se organizem teoricamente como sistemas médicos distintos e comparáveis em suas cinco dimensões, tendem a absorver traços de outras racionalidades, a desenvolver mais certas dimensões em momentos específicos de sua cultura de origem, ou a rejeitar determinados traços ou características em outros momentos.

A primeira fase da pesquisa, que comparou as diversas racionalidades em termos teóricos, como sistemas, foi de execução relativamente fácil, embora já se constatassem certas incoerências entre saber-prática, diagnose-terapêutica, doutrina médica e agir clínico. Consideramos estas incoerências como típicas da racionalidade médica em geral, independentemente do sistema médico, uma vez que coexistem, a nosso ver, dois paradigmas de conhecimento na medicina.

O primeiro paradigma seria um paradigma indiciário, de acordo com a definição de Ginzburg (1989), baseado na intuição, na observação empírica de

² HABERMAS, J. *Conhecimento e interesse*. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara, 1987.

"casos" singulares que se acumulam, formando um "acervo" do agente de cura, que lhe permite, num raciocínio de que não está ausente a intuição, vista como uma operação cognitiva sintética, "deduzir" o que tem o paciente, e como tratá-lo num momento específico da relação paciente-terapeuta, que é o momento que pode ser chamado em geral de "consulta".

O segundo paradigma, de ambição analítica, tendendo ao modelo de construção discursiva, senão teórica ao menos racionalizante, que caracterizou a construção histórica do conhecimento nas sociedades complexas, inclusive as orientais representadas em nosso estudo, está ligado ao estabelecimento de uma doutrina médica específica, que se opõe às outras, ou ao menos delas se distingue.

A primeira constatação, quando se comparam racionalidades médicas distintas, originadas em culturas distintas, ou até na mesma cultura (caso da homeopatia e biomedicina, na cultura ocidental moderna) é a grande diferença, ou divergência, entre as doutrinas médicas. Se se quiser estabelecer paralelos, pontos comuns ou complementares nas diversas medicinas, não se deve conduzir o estudo pela dimensão doutrina médica, pois as doutrinas acentuam os pontos de diferença, de dispersão e de conflito entre as racionalidades.

Esta foi uma conclusão útil da primeira fase do projeto, que nos levou a optar por estudar empiricamente as dimensões da diagnose e da terapêutica, ligadas à prática médica (portanto mais à arte do que à ciência médica), no sentido de chegarmos efetivamente a comparações entre as distintas racionalidades, bem como no sentido de apreendermos as distâncias, ou mesmo as oposições entre "ciência" médica e "arte" médica.

A comparação das racionalidades em plano teórico levou-nos também à constatação de que todo sistema médico complexo enraiza-se em uma cosmovisão, que preferimos denominar "cosmologia", devido ao grau de

sofisticação teórica que pode atingir tal visão, como é o caso da medicina ocidental, em que a visão cosmológica está sustentada na física clássica *newtoniana*. Uma cosmogonia é facilmente perceptível, por outro lado, nas medicinas ayurvédica e tradicional chinesa. Cosmovisão seria um termo mais preciso conceitualmente, para atender às diferenças entre cosmologia e cosmogonia presentes nas distintas racionalidades, reconhecemos, mas até o momento estamos empregando o termo cosmologia para acentuar o caráter elaborado e sistemático das diferentes cosmovisões presentes nos sistemas médicos em estudo.

Na verdade, estas cosmovisões impregnam não apenas as doutrinas médicas, como as outras dimensões da racionalidade; a morfologia, a dinâmica vital, a diagnose e a terapêutica, determinando, em grande parte, não apenas a arte médica, isto é, a prática terapêutica, mas também a ciência médica, isto é, a acumulação de conhecimentos concernentes ao conjunto das dimensões. Isto pode ser constatado tanto no caso das medicinas ocidentais (biomedicina, homeopatia), como no caso das orientais (ayurveda, medicina tradicional chinesa), o que reforça nossa opção pelo termo cosmologia para qualificar as raízes filosóficas das racionalidades médicas.

Com isto queremos também acentuar que não consideramos as cosmologias como o "lado obscuro" ou "simbólico" das racionalidades médicas, por oposição a uma possível cientificidade, ou pelo menos sistematicidade, em termos de conhecimento, das cinco dimensões básicas propostas. O simbólico, se for entendido como aquilo que é irredutível à racionalização, não está presente apenas nas cosmovisões, mas em todas as dimensões dos distintos sistemas médicos, através do imaginário coletivo, das representações sociais, das práticas sociais concretas enraizadas em valores, interesses e desejos individuais e grupais de toda sociedade, sendo estes sim os elementos irredutíveis à racionalidade conceitual, embora presentes em qualquer

racionalidade médica, inclusive nos conceitos mais elaborados da medicina ocidental.

A Medicina, Síntese Ativa de Ciência e Arte

Toda racionalidade médica, independentemente de seu paradigma, caracterizou-se historicamente por sintetizar em sua atividade social (*práxis*) uma "arte" ou técnica de curar doentes (*tekné*) e um conhecimento ou ciência de doenças (*gnose, episteme*).

A história dessa atividade talvez seja tão antiga como o próprio homem na Terra, e durante milênios não houve, aparentemente, na *práxis* desse mediador entre os homens, o sofrimento e a morte, divisão entre conhecimento e arte.

A origem do conhecimento do médico era **sagrada**, e na sua experiência pessoal **vivida**, que incluía uma socialização e um treinamento de natureza esotérica, este sintetizava *gnose* e *tekné*. Há ainda dois milênios e meio, tanto no Oriente como no Ocidente, isto é, tanto na China e na Índia como na Grécia, o saber-agir do médico tinha muito de **taumatúrgico**. O saber, sendo de origem sacra, o agente praticante tinha características sacerdotais. A corporação médica, se se pode empregar sem anacronismo esta expressão para designar os terapeutas desde esta época, tinha literalmente na arte da cura seu **sacerdócio**.

De qualquer forma, a natureza deste saber, nitidamente filosófico (religioso ou não), diferia essencialmente do saber moderno, que busca o conhecimento científico como ideal de verdade desde o século XVII. Neste contexto, a medicina ocidental pode ser vista como uma racionalidade específica, inserida em uma história cultural também específica, conhecida como **civilização ocidental**.

Na história dos últimos dois mil e quinhentos anos dessa civilização operaram-se mudanças culturais típicas relativas à racionalidade médica que fizeram com que a medicina ocidental tivesse um caráter *sui generis* em sua evolução. Essas mudanças tiveram algumas vezes o caráter de crises, com rupturas face aos padrões vigentes, e profundas conseqüências em relação às sínteses *gnose-tekné* ou *gnose - praxis - tekné*.

Mencionaremos a seguir alguns momentos que consideramos demonstrativos, em termos dessas crises, no sentido apenas de salientar este caráter *sui generis* da racionalidade médica ocidental. Nosso intento é mostrar que houve um percurso progressivo de separação entre os dois termos básicos que constituem o cerne da medicina, isto é, o conhecimento das doenças e a arte de curar. Queremos também afirmar que tal percurso não foi seguido pelas medicinas orientais até muito recentemente, isto é, até o século XX.

Essa caracterização é importante para estabelecermos diferenças fundamentais na cosmologia ocidental face às que informam as medicinas Chinesa e Ayurvédica. Diferenças importantes para a compreensão das doutrinas médicas, dos sistemas de diagnose e intervenção terapêutica das medicinas orientais, e mesmo para a homeopatia, que conservou, embora implícita, parte da cosmologia tradicional do ocidente, com suas raízes pré-cristãs e cristãs.

Crises e Mutações na Racionalidade Médica Ocidental

A primeira crise e transformação na estrutura da racionalidade médica ocidental significativa pode ser situada no que preferimos chamar de **momento hipocrático a escola hipocrática**.

Momento, não só porque abrange mais de um século, podendo ser situado entre os séculos V e III antes de Cristo, mas também porque envolve mais escolas que a de Kós (inclusive a de Knidos), famosa por Hipócrates e seus discípulos.

Este momento assinala um período de discussões e controvérsias no pensamento médico, com uma forte tendência à racionalização, ao estabelecimento de teorias sobre as doenças e sobre métodos terapêuticos, sobre o papel da filosofia e da natureza na medicina como sistema teórico e como prática (arte) de cura.³

Além da tendência à sistematização, há a formação e consolidação da corporação médica como portadora do saber filosófico (portanto, verdadeiro) sobre as doenças e os doentes, com a afirmação de um *esprit de corps* pronunciado, não sem a oposição de outros setores da sociedade, inclusive de intelectuais como Aristóteles, por exemplo, que caricaturiza os médicos em suas peças.

Há muita especulação ainda hoje sobre os contatos que teriam existido nesse momento entre a medicina grega (ocidental) e as medicinas hindu e chinesa (orientais), através das viagens de filósofos como Platão, e de médicos. É preciso não esquecer que as ilhas gregas, sobretudo as jônicas, eram então as portas da Ásia, e que os gregos dos Estados-cidades eram

³ Um exemplo desse grande movimento racionalizador são as discussões entre as escolas médicas de Kós (hipocrática) e Knidos.

grandes navegadores. Entretanto, não obtivemos dados precisos sobre esses contatos prováveis, nem foi nosso objetivo nos aprofundarmos sobre este tema. É preciso ressaltar, no entanto, que os séculos V a II antes de Cristo assinalaram, tanto no Ocidente como no Oriente, uma expansão cultural importante, e no plano da medicina essa expansão é significativa tanto em termos da doutrina médica, como da semiologia e da classificação das doenças (diagnose).

No que concerne à medicina ocidental, há uma laicização importante do conhecimento médico, que busca sua base na **filosofia**, que é a Ciência da época, por oposição a saberes mágicos, xamânicos.

Mas, ainda nesse momento, a arte de curar conduz ao conhecimento das doenças, o objetivo preciso da medicina é restabelecer a saúde dos doentes, e o homem é um microcosmo cujo funcionamento está inscrito nas leis do Cosmo. A natureza é parte do homem, através de seus elementos fundamentais, e este é parte integrante da natureza. Sua saúde reside em equilibrar seus componentes naturais da maneira mais harmônica possível. Neste contexto a natureza tem ainda realmente *vis medicatrix*, força medicadora.

Mas uma tendência a separar teoria das doenças, semiologia e terapêutica aparece desde esse momento. Desde aí a medicina ocidental começa a se tornar **Ciência**, isto é, uma forma teórica de classificar doenças, síndromes, sintomas e de buscar uma explicação causal para esses fenômenos.

O segundo grande momento de crise e mutação na racionalidade médica ocidental pode ser situado entre o fim do renascimento e o início do classicismo moderno, isto é, nos séculos XVI e XVII.⁴

As disciplinas científicas básicas da medicina estruturam-se desde então, com a anatomia, a fisiologia e a patologia. A ciência, como projeto de estruturação do saber médico, sobrepõe-se ao conhecimento do adoecer (*gnose*) como fruto de experiência da arte de curar (*tekné*), isto é, a *epistémé* torna-se superior a *gnosis* e à *tekné* provenientes da *práxis* voltada para o restabelecimento da saúde dos doentes.

Esta transformação médica está, como afirmamos em outro momento, inserida em um "conjunto de transformações histórico-sociais que perpassou (a sociedade) desde o fim da Idade Média, sobretudo na Idade Moderna, e com o processo (posterior) de industrialização e expansão do capitalismo".⁵

A ascensão da ciência como forma socialmente legítima — depois legal — de produzir conhecimento, com o progressivo descrédito da arte, e da experiência comum, cotidiana, é um fato cultural mais amplo que a transformação interna à medicina. Do nosso ponto de vista, a medicina apenas exprime e ilustra com radicalidade um processo de racionalização amplo que atingiu o Ocidente, desde o classicismo grego, mas crescentemente, com o capitalismo moderno, como salientaram filósofos, historiadores e sociólogos como Max Weber e Habermas.

Pode-se dizer que desde o século XVII o projeto epistemológico da medicina ocidental passou a ser *produzir conhecimento sobre as doenças*.

⁴ Ver LUZ, M. T. *Natural, Racional, Social. op. cit.*

⁵ Ver LUZ, M.T. *II Seminário do Projeto Racionalidades Médicas*, IMS/UERJ, dez. 1992, p. 7-8.

Coerentemente, a arte de curar doentes teve um estatuto menor com o passar dos séculos e com o aumento de informações (e de técnicas de obtenção de informação) sobre as doenças.

Neste contexto, no interior das cinco dimensões essenciais da racionalidade médica, a diagnose teve hegemonia progressiva sobre a terapêutica; mesmo a terapêutica foi sendo cada vez mais orientada pela busca sistemática de identificação e combate de doenças, e não mais pelo restabelecimento do equilíbrio de sujeitos doentes.

Um fosso teórico e prático tendeu a se formar no interior da medicina vista como *práxis*, isto é, concretamente, na *clínica*.

Pois os terrenos de ação-intervenção médica (*praxis-tekné*), por um lado, e de fonte de conhecimentos médicos (*epistémé*), por outro lado, permaneceram sempre o corpo do doente, ainda que examinado sob a forma de partículas cada vez menores, freqüentemente dissociadas entre si, ou da totalidade que as supõe.⁶ Mas este corpo, terreno de experimentação biomédica, não será mais visto pela medicina como integralidade individual viva, nem a vida individual de sujeitos interessará mais à ciência médica moderna.

Entretanto, o combate à morte, sobretudo à morte de grupos populacionais específicos (morte coletiva) continuará sendo um objetivo central da medicina ocidental ao longo de mais de três séculos.⁷ Deste ponto de vista, a *eficácia terapêutica*, entendida como vitória sobre as doenças e controle da morte, levará a prática médica a pesquisar com maior afinho as *drogas*

⁶ Ver CAMARGO Jr., K.R. "Racionalidade da Medicina Ocidental Contemporânea" in: LUZ et cols. *II Seminário do Projeto Racionalidades Médicas*, IMS/UERJ, 1992.

⁷ LUZ, M.T. *Natural, Racional, Social. op. cit.*, Cap. VI.

consideradas aliadas do médico em seu combate. Coerentemente os fármacos e, a partir do fim do século XIX, a própria indústria farmacêutica, serão ora a lança, ora o escudo da clínica moderna. Lança e escudo muitas vezes perigosos, quando não mortais para os doentes, mas supremo critério de verificação de eficácia da prática clínica.

Deste modo, a teoria das doenças, com experimentação em corpos doentes ou mortos, por um lado, e a administração (quase sempre experimental) de fármacos a doentes, por outro lado, constituirão o embrião da clínica contemporânea no século XVIII, o ovo de onde nascerá, no século XIX, a medicina ocidental como a conhecemos até os dias de hoje.

Assim, o período final do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX constituem, a nosso ver, o terceiro momento de crise e mutação na racionalidade médica ocidental. Este momento assinala, segundo Foucault, no *Nascimento da Clínica*, o surgimento de uma nova forma de pensar e agir médicos, bases da **clínica**, vista como disciplina contemporânea médica.

Nesses pensar e agir a vida passa a ser vista através da morte (cadáveres examinados) e o instrumento de ação fundamental é o "olhar clínico", sistematizador do trajeto das doenças em direção à morte, trajeto que pode ser atalhado pela **intervenção médica** através do fármaco ou do bisturi.

Os médicos passam a ser, nesse contexto, não mais os aliados da vida, mas os combatentes da morte. Conhecer o inimigo, seus porta-vozes (doenças) e tropas (sintomas, síndromes), suas táticas e estratégias ("evolução" das doenças) tornam-se a prioridade básica da ciência médica.

Quanto à terapêutica, tornar-se-á, nesse imaginário bélico, um **arsenal** de drogas, um conjunto de armas de sofisticação e poder de fogo variados. Inclusive contra os doentes.

Mas é preciso continuar atento a que o fundamental, embora não exclusivo, na nova arte de curar, não é restabelecer a saúde dos doentes individuais, mas combater as doenças e controlar as mortes em plano coletivo.⁸ Deste ponto de vista, a clínica é, desde o seu berço contemporâneo, como quer Foucault, **medicina social**.

Neste contexto é compreensível que os defensores de uma "arte de curar doentes", ao estilo tradicional da medicina, sejam vistos como portadores de um projeto epistemologicamente atrasado e clínica e socialmente inoperantes. Um projeto **superado**.

Uma medicina baseada em "princípios" ou "leis" de cura, isto é, centrada na terapêutica entendida como restabelecimento da saúde de sujeitos (caso da homeopatia), não faz mais sentido para o projeto da clínica que se tornou progressivamente hegemônica.

Mas esta hegemonia não se estabeleceu sem crises e divisões na medicina. Ao contrário, pode-se afirmar, com Coulter,⁹ que a medicina ocidental moderna, sobretudo a contemporânea, é fruto de um **cisma** que separou profundamente **ciência médica** e **arte de curar**.

A principal manifestação desse **cisma** é o surgimento da homeopatia no alvorecer do século XIX, na contracorrente da tendência dominante do pensamento médico.¹⁰ A medicina homeopática afirmará a supremacia da **arte de curar** sobre a **teoria das doenças**, e propugnará por uma **ciência da terapêutica**, isto é, de uma clínica (arte de curar) "verdadeiramente experimental". Criticará, através de seu fundador, Samuel Hahnemann, a

⁸ LUZ, M.T. *Natural, Racional, Social*, idem.

⁹ COULTER, H. *Divided Legacy, The schism in Medical Thought*

¹⁰ LUZ, M.T. *Natural, Racional, Social*, op. cit., Cap. VI

ausência de princípios terapêuticos da medicina do final do século XVIII e início do século XIX.

Criticará também que os doentes sejam o "campo experimental" da clínica, onde o emprego aleatório e assistemático das drogas as mais variadas acaba por danificar-lhes definitivamente a força vital, transformando a tarefa de recuperação da saúde num esforço sobre-humano, tanto para pacientes como para terapeutas.

Advogará a descoberta de "leis de cura", adequadas aos doentes através do princípio da semelhança ("o semelhante cura o semelhante"), experimentado em homens sadios (e não em doentes), com fármacos diluídos ao ponto da imponderabilidade ("dinamização"), no sentido de estimular nos doentes a energia vital desequilibrada.

O projeto da medicina homeopática de estabelecimento de uma **ciência da terapêutica** tenderá a ser cientificamente marginalizado, num contexto de valorização progressiva da **diagnose** como elemento fundamental da ciência das doenças.

Os médicos tenderão a tornar-se **homens de ciência**, e não mais artesãos da cura. A arte de curar tenderá a fazer parte do passado da medicina.

Os hospitais não serão mais, como no fim da idade média, nem "morredouros", nem "loais de cura" (como no fim do século XVIII e início do XIX), segundo as palavras do filósofo do *Nascimento da Clínica*. Serão cada vez mais verdadeiros laboratórios de investigação biomédica e clínica, e tornar-se-ão, no século XX, a principal instituição de transmissão do conhecimento médico.

Assim, o ensino das escolas médicas desloca-se progressivamente para os hospitais, transformados em centros de pesquisa e reprodução do conhecimento, desde o final do século XIX. Esse deslocamento atingirá seu auge no século XX, após a segunda guerra mundial, com o florescer das especialidades médicas e das indústrias farmacêutica e de equipamento médico-hospitalar.

Às faculdades restará o ensino das disciplinas "básicas" da medicina, como a anatomia, a patologia, a fisiologia e a fisiopatologia, e a "teoria" das disciplinas das especialidades.

Nesse contexto é que podemos situar o quarto momento de crise e mutação internas da racionalidade médica ocidental ou, se preferirmos empregar uma expressão em moda, de mudança em seu paradigma.

Esse quarto momento estabelece uma cisão não mais entre **pensamento médico** e a prática médica, mas no interior mesmo da **prática clínica**. Tal cisão se manifesta no agir terapêutico, determinada pelo grande **avanço** da tecnologia instrumental médica, totalmente voltada para a diagnose das doenças.

A tecnologia médica, materializada nos instrumentais diagnóstico e cirúrgico, grandes auxiliares da clínica, interpõe uma **Tekné** já constituída entre o médico e o corpo do doente, ocasionando um completo alheamento entre terapeuta e paciente. Por outro lado, esta interposição maciça do instrumental médico leva à alienação do doente face ao seu próprio corpo e à fetichização do equipamento médico (e do fármaco, naturalmente). Uma das conseqüências dessa interposição tecnológica na **práxis** médica, contemporânea, talvez a mais importante, é a implosão, com a conseqüente perda, da relação milenar terapeuta-paciente.

Em resumo, podemos constatar, na medicina ocidental contemporânea, a convivência contraditória de uma tripla cisão: a cisão entre ciência das doenças e arte de curar (*epistémé/tekné*) desenvolvida no pensamento médico ao longo dos últimos três séculos; a cisão na prática médica de combate às doenças entre diagnose e terapêutica (*práxis*), desenvolvida sobretudo a partir do fim do século XIX; finalmente a cisão, no interior do agir clínico (*Tekné*), da unidade relacional médico-paciente, através do progressivo desaparecimento do contato com o corpo do doente, pela interposição de tecnologias "frias" diagnósticas e terapêuticas, verificada a partir da 2ª metade do século XX.

Esta tripla cisão constitui, a nosso ver, uma das explicações sócio-antropológicas possíveis para a grande procura de outra racionalidade médica, nos últimos 20 anos, no mundo ocidental, configurando o florescimento na nossa sociedade do que se denominou, em termos do *establishment* médico, de "terapêuticas alternativas".

Esta cisão pode ser também a explicitação do profundo mal estar que atinge atualmente esse *establishment*, sob a designação de "crise da medicina", ou, recentemente, de "crise de paradigma da medicina".

Racionalidades Médicas e Cosmologias

O que pretendemos salientar em nosso estudo é que essas cisões que atingiram o sistema médico ocidental não atingiram os sistemas médicos orientais (medicina tradicional chinesa e medicina ayurvédica) e não tocaram a medicina homeopática, na medida em que a arte de curar continuou a ser o elemento predominante do seu conhecimento, e que a relação de cura e o restabelecimento (ou mesmo a expansão) da saúde dos doentes continuou a ser o fundamento da sua prática.

Por outro lado, cosmologias que integram homem e natureza numa perspectiva de macro e micro universos, e que postulam a integralidade do sujeito humano como constituída de aspectos psicobiológicos, sociais e espirituais, embasam as cinco dimensões das medicinas orientais e da homeopatia, tendo profundas repercussões tanto nas doutrinas médicas, quanto nos sistemas diagnósticos e terapêuticos dessas medicinas. Essa dupla integração leva a considerar a doença como fruto da ruptura de um equilíbrio ou harmonia interna, no que concerne ao micro universo que constitui o homem relacional, no que concerne às relações entre o homem e o meio no qual se insere: natural, social e espiritual.

Pode-se até encontrar, nessas medicinas, um inventário classificatório das doenças existentes; entretanto, elas não têm interesse em si mesmas, devendo ser referidas, tanto em termos diagnósticos, como terapêuticos, aos sujeitos individuais e suas constituições.

Trata-se, assim, nos casos dos três sistemas mencionados, de "medicinas de constituições", nas quais o elemento cosmológico desempenha um papel importante na determinação das constituições individuais.

Na racionalidade médica ocidental, a dupla integração mencionada é considerada não existente ou "hipotética", isto é, destituída de base científica. Não constitui, por isso mesmo, objeto de investigação da ciência médica, na medida em que o objeto epistemológico desse sistema, como já salientamos, é a **doença**, sua identificação, sua classificação, e a busca de suas causas (etiologia). Conseqüentemente, o objetivo da medicina não é mais o restabelecimento da saúde de sujeitos individuais, mas o combate à doença e à morte coletivas, combate mediatizado por **instituições médicas públicas** ("medicina social").

Finalmente, como afirmamos em outro trabalho: *"na visão ocidental predominante, o sobrenatural, ou o espiritual, é identificado com o místico, com a visão de Deus, dos Anjos, dos Santos, dos espíritos, enfim de toda a doutrina ligada à teologia judaico-cristã, contra a qual se posicionou desde o seu início a ciência moderna"*.¹¹ Desta forma, a continuidade dos "mundos" individual, natural, social e espiritual é impensável. O advento da doença como expressão da ruptura da harmonia dessa continuidade é considerado absurdo.

Nas medicinas tradicional chinesa, ayurvédica e homeopatia, ao contrário, toda doença é fruto de um desequilíbrio de forças naturais (materiais) e sobrenaturais (imateriais), desequilíbrio entendido como **ruptura de harmonia**, quebra de uma certa ordem cósmica em movimento, que inclui o homem ao mesmo tempo como expressão e partícipe. O absurdo seria não considerar essa harmonia e a inter-relação dos elementos do macro e do micro cosmos.

Certamente os raciocínios analógicos predominam sobre os analíticos, e os princípios da similitude e da simpatia, de que nos fala Foucault nas *Palavras e as Coisas*, são dominantes em relação ao princípio da diferença, ou da alteridade.

O saber médico, e portanto a racionalidade médica suposta a esse saber é, neste caso, necessariamente distinta daquele originado pela ocidental científica moderna. Distinção que se exprime nas 5 (cinco) dimensões da racionalidade: na doutrina médica, na morfologia e na dinâmica vital humanas, nos sistemas de diagnose e terapêutica.

¹¹ LUZ, M.T. *Racionalidades Médicas e Sistemas de Conhecimento*, roteiro teórico para uma abordagem comparativa de "Medicinas Alternativas" in II Seminário do Projeto Racionalidades Médicas, IMS/UERJ, 1992, p. 22.

Mas essa distinção não significa necessariamente, na materialidade das cinco dimensões, e sobretudo na prática terapêutica, oposição ou exclusão. Na verdade, há muitas complementaridades entre os diversos sistemas médicos, compreensíveis quando se trata das medicinas "exóticas" comparadas entre si, mas surpreendentes quando verificadas face à medicina ocidental.

Racionalidades Médicas e "Medicinas Alternativas"

Não é outra coisa o que podemos verificar na tendência atual da medicina ocidental de incluir, em seu "arsenal terapêutico", técnicas terapêuticas das medicinas orientais, como a acupuntura e a moxabustão, ou a prática dos exercícios de meditação ou artes marciais, ligados tanto à medicina tradicional chinesa como à ayurvédica (tai chi chuan, yoga).

É verdade que essa inclusão é, na maioria das vezes, mera apropriação pela medicina ocidental de aspectos terapêuticos que são parte de um outro sistema coerente e integrado. Verifica-se, neste caso, uma descontextualização das racionalidades médicas orientais, com um conseqüente desprezo pelo significado filosófico e médico dessas medicinas, e uma hegemonização da biomedicina sobre as outras, sobretudo em serviços públicos de saúde.

Entretanto, o esforço de reconhecimento de eficácia quanto a esses aspectos, e a tentativa de comprová-los experimentalmente no sentido de legitimá-los, também não deve ser menosprezado como um fato de importância crescente na medicina ocidental nos últimos dez anos (pelo menos).

Também o reconhecimento da homeopatia como terapêutica preferencial ou complementar por muitos médicos de especialidades diversas

(pediatria, alergologia, imunologia e doenças ditas psicossomáticas) não deve ser deixado de lado, devido a sua significação político-institucional, em que pese o fato de a própria homeopatia já ser uma especialidade médica há mais de uma década no Brasil, e de ser, juntamente com a acupuntura e a fitoterapia, uma forma de tratamento institucionalizada desde 1988, com a criação do Sistema Único de Saúde (S.U.S.) brasileiro.

O que queremos salientar com essas observações é que, apesar de se tratar de paradigmas médicos inegavelmente distintos, orientados por cosmologias que conflituam nos seus aspectos principais, originando doutrinas médicas opostas em vários pontos, as racionalidades médicas homeopática, orientais e científica moderna têm pontos de paralelismo e de encontro nas dimensões da **diagnose** e da **terapêutica**.

Em termos gerais podemos dizer que é nos sistemas diagnóstico e terapêutico que tende a haver maior concordância e complementariedade (ou pelo menos menor grau de conflito e exclusão) entre as racionalidades médicas. Mas isto não nos autoriza a afirmar que no plano da **prática**, do **agir clínico**, as diferenças se desfazem. Entretanto, é evidente que a superação de contradições entre os sistemas passa muito mais pela **arte da cura** que pela **ciência da doença** (ou do adoecer humano). Em princípio porque sempre que a finalidade básica milenar da medicina, **curar doentes**, é mobilizada, a questão da terapêutica passa a primeiro plano e as diferenças de doutrina médica entre as racionalidades são amenizadas neste caso, e uma abertura para outros sistemas terapêuticos pode ser observada, ao menos no caso da **medicina ocidental**, isto é, tanto da medicina científica como da homeopática.¹²

¹² Não tivemos ainda a oportunidade de observar se o mesmo acontece em relação às medicinas tradicional chinesa e ayurvédica face à medicina ocidental, mas é muito provável que a integração seja ainda maior no plano terapêutico, face as questões sócio-culturais que caracterizam as relações das sociedades chinesa e hindu com a civilização ocidental.

As referências obtidas indicam que há grande integração, no nível da atenção médica de massa, entre ayurveda, ou M.T.C., e medicina ocidental.

No que concerne à questão do sistema diagnóstico, os paralelismos e pontos de encontro são muito mais freqüentes entre as racionalidades que partilham um paradigma **vitalista**, isto é, as medicinas homeopática, tradicional chinesa e ayurvédica.

Pois essas medicinas têm em comum o mesmo **objeto**, o ser humano doente, e o mesmo objetivo, que é **curar o indivíduo**, restabelecendo-lhes a saúde, ou expandindo-a.

Além disso, partilham uma cosmologia integradora da natureza e do homem e, no interior do homem, de seus aspectos natural e espiritual (sobrenatural).

O meio ambiente, natural e social, bem como as **circunstâncias** do adoecimento têm, para essas medicinas, grande importância no estabelecimento de diagnósticos.

Outros elementos, de natureza **qualitativa**, como duração, intensidade, modalidade, lateralidade, ritmo e profundidade dos sintomas, vistos tanto nos planos orgânico, como sensorial, emocional e espiritual (domínios da existência, da sensibilidade, da vontade, da liberdade) são considerados de grande importância nesses sistemas diagnósticos. O que dá origem tanto a uma semiologia minuciosa e detalhada, como a diversas técnicas de exame e obtenção de diagnóstico (ver quadro resumo em anexo).

Os pontos de contato, nesse caso, com a medicina ocidental, são muito poucos. Mas **existem**, como no caso da palpação, da ausculta, do exame de pulso (ou pulsos), de olhos, língua, unhas, etc. Em suma, a clínica convencional, ligada à arte de curar, desprovida de sofisticação tecnológica e em grande parte hoje superada pela medicina contemporânea, tem pontos de

encontro com os sistemas de exame-diagnóstico das medicinas tradicionais, embora o objetivo central do diagnóstico possa ser diferente em cada paradigma. No caso da clínica ocidental trata-se de esclarecer a **doença**, e no caso das medicinas tradicionais, o **desequilíbrio específico do doente**, face a sua constituição.

No que concerne à **dinâmica vital**, também os pontos de encontro, as semelhanças concentram-se nas racionalidades que partilham o paradigma bio-energético ou vitalista, isto é, a homeopatia, a medicina tradicional chinesa e a ayurvédica. Porque a presença da **vida** entendida como **movimento**, por um lado, e como **energia**, ou **força**, ou **sopro**, por outro lado, fazem destas medicinas sistemas de análise do dinamismo vital humano, tanto no que concerne ao estado de saúde como ao adoecimento dos indivíduos. Mesmo a fisiopatologia é a fisiopatologia do enfermar-se, isto é, do processo de aprofundamento do adoecer dos sujeitos, enquanto que na medicina ocidental trata-se sobretudo da fisiopatologia de **doenças**; de fato, trata-se de uma **fisiopatologia**. Para as medicinas vitalistas (que neste trabalho incluem a medicina homeopática, a tradicional chinesa e a ayurvédica), a fisiopatologia das doenças pode ser considerada como um elemento de apoio para a compreensão da dinâmica vital dos sujeitos, mas não poderá ser tomada isolada ou principalmente como guia da diagnose ou da terapêutica.

Finalmente, no caso da morfologia ("anatomia") humana é que aparecem as maiores diferenças entre as medicinas tradicionais (e a medicina homeopática pode ser incluída, **até certo ponto**, entre eles) e a medicina ocidental contemporânea.

Não apenas o sistema de denominações é muitas vezes diferente, como o recorte do corpo humano, de seus limites e componentes, pode ser totalmente distinto. Inclusive no que concerne à própria noção de **corpo**.

Pode-se ter uma compreensão de **corpo energético**, que constitui uma verdadeira "anatomia energética", nas medicinas tradicionais, como no caso da medicina tradicional chinesa, através dos canais de meridianos com seus pontos, como na ayurveda, com sua escala de corpos do "grosseiro", ou mais denso, ao mais sutil, ou mesmo na homeopatia, onde um sistema de circulação energética, suposto ao sistema orgânico, através do percurso da energia vital, permanece implícito (não elaborado conceitualmente), embora postulado.

Também a definição e a compreensão de órgãos e sistemas é muito dispar, exprimindo a diversidade de contextos culturais, com suas representações e símbolos distintos entre si. No entanto, analogias e aproximações mesmo nesse campo podem ser feitas, sobretudo entre as medicinas tradicionais, é certo, mas também com a medicina ocidental.

Em outras palavras, queremos dizer que as racionalidades médicas aqui estudadas são **concretamente** comparáveis em todas as suas dimensões, o que nos abre a possibilidade de estabelecer critérios de verificação de práticas **adequadas a essas racionalidades**, isto é, sem o reducionismo habitual a uma racionalidade cultural e politicamente dominante como a nossa.

O estabelecimento de categorias analíticas capazes de nos levar a esses critérios constituiu o passo seguinte no desenvolvimento do projeto.

Diagnose e terapêutica nas Racionalidades Médicas

Como acentuamos anteriormente, é muito mais fácil encontrar pontos de identidade (ou de conflito) quando se estudam medicinas que partilham um mesmo paradigma. Ainda que se considerem diferenças paradigmáticas, desde que se aprofundem a descrição e a análise dos traços característicos da diagnose e da terapêutica, podem-se encontrar pontos de contato e de comparação (semelhança, identidade, oposição) entre distintas racionalidades médicas, independentemente do paradigma a que pertençam.

A questão da definição e análise de categorias básicas para cada uma dessas dimensões tornou-se, portanto, muito importante para se estabelecerem critérios de comparação em termos de práticas, questão central para a estratégia metodológica da segunda fase da pesquisa.

No que concerne à diagnose, as categorias de sintoma (expressão do sofrimento dos sujeitos) e sinal (indícios objetiváveis de doenças) mostraram-se universais e indispensáveis para lidar com essa dimensão, embora o peso que cada uma tenha no agir terapêutico varie com a racionalidade e seu paradigma. Esse peso é significativo em termos de comparação de sistemas e de práticas. No caso da medicina ocidental, por exemplo, o peso dos sintomas, identificados à subjetividade dos pacientes, tende para zero em relação ao estabelecimento do diagnóstico, atualmente centrado em procedimentos tecnológicos de objetivação da doença. No caso das medicinas tradicionais (homeopatia, medicina tradicional chinesa, ayur-veda), dá-se o inverso: o peso dos sintomas é máximo na atribuição do diagnóstico, pois se trata de estabelecer o diagnóstico de um desequilíbrio ou da desarmonia de sujeitos singulares.

Além dessas categorias, a de normalidade mostrou-se também importante para a dimensão da diagnose, na medida em que se percebeu que todos os sistemas médicos em análise partiam explicitamente da idéia que a medicina é uma forma de normalização da vida, ou do ser vivo. A idéia de ordem vital, de que nos fala Canguilhem¹³ é, portanto, um ponto comum às racionalidades. Diagnosticar é apontar a natureza, as características, as origens ou a causa da desordem que atingiu o ser humano enquanto organismo e psiquismo ou, se quisermos adotar uma expressão menos médica, enquanto corpo e espírito.

Evidentemente a representação, ou mesmo a conceituação do que seja desordem vital, pressuporá implícita ou explicitamente a vida social e suas regras, variando de acordo com as culturas em que se inserem os distintos sistemas médicos. Neste particular, a dimensão da cosmologia torna-se muito importante, na medida em que estar "fora da ordem", isto é, desequilibrado, portanto doente, é estar, de acordo com as medicinas tradicionais, fora dos princípios de ordenação do cosmos, ou da vida.

Para essas medicinas o meio ambiente do ser humano, sua vida natural e social, bem como as circunstâncias em que adoecemos, têm grande importância para o estabelecimento do diagnóstico. Outros elementos explicativos do adoecer, de natureza qualitativa, já mencionados, são fundamentais na ocasião da manifestação dos sintomas, tanto no plano orgânico, como sensorial, emocional, caracterial e espiritual e determinantes para a diagnose. O que origina uma semiologia muito detalhada, bem como diversas técnicas de exame para obtenção do diagnóstico, todas dependentes do agir do terapeuta.

¹³ CANGUILHEM, G. *O Normal e o Patológico* (trad. bras.). RJ: Forense Ed., 1978.

Neste caso, os pontos de contato com a medicina ocidental são poucos, mas existem. Isto pode ser exemplificado em relação ao exame feito pelo médico, com a palpação, a ausculta, a tomada do pulso (ou pulsos, de acordo com o sistema), de olhos, de língua, de unhas, etc. A clínica clássica, recomendada nos livros de semiologia, desprovida da sofisticação tecnológica da medicina contemporânea, tem vários pontos de encontro com o sistema de anamnese e exame para diagnóstico das medicinas tradicionais, embora o objetivo do diagnóstico seja diferente, de acordo com seu paradigma médico. No caso da medicina ocidental trata-se de esclarecer qual é a doença, e em que fase de evolução ela se encontra, tendo como base as categorias de lesão e entidade, enquanto que nas outras trata-se de estabelecer a origem, o tipo, o estágio e a profundidade do desequilíbrio do sujeito, tendo como base teórica uma classificação prévia de constituições e as categorias de suscetibilidade e "terreno" mórbido.

Em relação ao sistema de intervenções terapêuticas, as categorias básicas divergem para cada paradigma. No caso da medicina ocidental, a finalidade básica da terapêutica deve ser a eliminação ou o controle da doença, o que pode ser mensurado pela redução dos sintomas aos índices estabelecidos de normalidade. As categorias de controle ou erradicação da doença e normalização dos sintomas são estratégicas, tendendo a se identificar à cura nesse sistema, embora a idéia de cura neste sistema não seja importante face à de normalidade.

No caso das medicinas tradicionais, onde se pode incluir, neste caso, a homeopatia, a categoria de cura entendida como restituição da saúde, isto é, de equilíbrio ordenado do sujeito, é que é estratégica. Mas de qualquer maneira, o critério de estabelecimento da cura é também ligado à redução dos sintomas, embora neste caso se trate de sintomas do sujeito, e não da entidade clínica.

Além da divergência sobre o que é cura, há também a divergência sobre o que curar, e como considerar que há cessação ou redução de sintomas. No caso das medicinas tradicionais, a questão do sofrimento dos sujeitos, e da busca de alívio desse sofrimento, comanda a orientação sobre a terapêutica, caracterizando-as basicamente como arte de curar ou "aliviar sofrimento". Há aí uma orientação que se poderia chamar, em princípio, de subjetivista, contrastante com a orientação objetivista da medicina ocidental contemporânea, para a qual a eliminação da entidade, ou ao menos seu controle, é o fundamental. É sobretudo por isso que a dimensão da diagnose é predominante sobre a da terapêutica na racionalidade médica ocidental.

De qualquer maneira, as categorias de sintomas, sofrimento e dor; ou normalização, reequilíbrio, restabelecimento ou cura, são categorias significativas para os sistemas examinados, no que concerne à dimensão da terapêutica. Os sentidos atribuídos por cada um dos sistemas a essas categorias é que variam e que foram aprofundados pela pesquisa na sua segunda fase, fase empírica.

O trabalho de campo

O estudo empreendido na primeira fase, de natureza teórica, levou-nos à certeza de que todas as questões até aqui mencionadas não são questões menores, em termos da comparação de sistemas médicos complexos, e serviram para aplainar, em termos conceituais, o caminho do estudo empírico previsto para a segunda fase do projeto. Serviu também para nos avisar das dificuldades que encontraríamos no emprego das categorias analíticas que serviriam como instrumental para a comparação das racionalidades no campo da diagnose e da terapêutica, dimensões reconhecidas como adequadas para a comparação de racionalidades, pois

implicam a prática médica, ao mesmo tempo em que implicam necessariamente as dimensões teóricas (morfologia, dinâmica vital e doutrina).

A busca dessas categorias consumiu um ano de trabalho (1994) e ainda não podemos considerá-la acabada, se levarmos em consideração a perspectiva estritamente comparativa. Conseguimos elaborar um conjunto de categorias adequadas para cada racionalidade, no que concerne a sua diagnose e a sua terapêutica, e algumas categorias fundamentais presentes em qualquer sistema médico, como sintoma, sinal, equilíbrio (ou desequilíbrio), normalidade (ou anormalidade), no que concerne à diagnose, e dor, sofrimento, piora, melhora, cura, curável e incurável, no que diz respeito à terapêutica. Além disso, chegamos à constatação de que os sistemas médicos estudados, e acreditamos, todos os sistemas médicos, tendem a ser normativos, estabelecendo regras de funcionamento ideal para o organismo e a vida humana em geral, e colocando no desvio da anormalidade (no caso da nossa cultura, da patologia) as manifestações vitais individuais ou coletivas que se afastem dessas regras. O ser humano não é socialmente livre para determinar o que é sua saúde, ou para como conduzir o destino de seu corpo: a medicina é a instância social legitimada para estabelecer o que é a ordem vital.

O trabalho de campo, iniciado em julho de 1995, evidenciou diferenças não apenas nas racionalidades médicas, o que já era esperado, mas nas formas de atendimento institucional nos diversos serviços onde as entrevistas e as observações etnográficas preliminares foram realizadas.

Uma das constatações imediatas do "campo" é que a lógica e a estrutura material dessas formas de atendimento influem decididamente na implementação das racionalidades médicas. Inversamente, a própria lógica de um determinado sistema médico, como a medicina ocidental contemporânea, determina formas de atendimento muitas vezes incongruentes com o que

constitui, teoricamente, o âmago da sua própria racionalidade. Estabelecem-se, assim, limites institucionais para o desempenho dos sistemas médicos, sejam eles quais forem. Isto pode ser observado com mais clareza no atendimento ambulatorial da medicina ocidental, tanto nos serviços do hospital universitário, como no P.A.M. (Posto de Atenção Médica), e no posto de saúde, que constituem os terrenos da presente investigação. No entanto, os mesmos limites podem ser observados com relação à medicina tradicional chinesa e, em menor grau, na medicina homeopática.

Um problema metodológico imediato colocou-se nesta "entrada em campo": estariam dadas as condições objetivas para a observação sistemática desses sistemas, uma vez que o obstáculo introduzido pela caótica organização institucional interfere no seu desempenho? Que comparatividade se pode efetivamente estabelecer entre sistemas médicos que não têm condições de se exercer plenamente enquanto arte de curar?

Esta questão, importante para qualquer estudo de avaliação de programas de atenção médica, não é facilmente contornável. Entretanto, numa situação como a do sistema público de saúde brasileiro atual, não se pode observar nem avaliar programas de atendimento em condições "ideais": a própria precariedade com que a atenção médica é prestada torna-se um dado para se estimar sua capacidade de atendimento à saúde da população.

No caso da medicina ocidental contemporânea, por exemplo, o fato de ser totalmente especializada em termos de saber cria uma impossibilidade prática de acompanhar tratamentos de sujeitos individuais, pois os indivíduos estão parcelados nas especialidades, quase nunca voltando ao médico "original", isto é, aquele que deu início ao processo de medicalização, e que serviu de fato apenas como um profissional de triagem de especialidades. Não há, também, um médico único, que atende a um determinado paciente

individual. Em suma, não há um paciente para um médico, ou um médico para um paciente nesta racionalidade.

Neste caso específico é necessário, para se manter o plano original da investigação, entrevistar vários indivíduos, em fases diferentes de tratamento, e não um mesmo indivíduo que se possa entrevistar três vezes em um ano, acompanhando diferentes fases de seu tratamento com um terapeuta, como se procede para com a homeopatia e a medicina tradicional chinesa (serviços de acupuntura e massagens). São diferentes indivíduos pacientes, em diversos momentos de seu tratamento, que dão o testemunho sobre a efetividade da medicina ocidental, através do tratamento a que vêm se submetendo. O fato mesmo de continuarem a freqüentar tal ou qual ambulatório (de determinada especialidade), testemunha já uma certa eficiência do tratamento, ao menos no plano institucional, já que a tendência observada em diversos estudos, e confirmada também neste, é a de freqüente abandono, por parte dos pacientes, para grande frustração dos médicos e possivelmente dos doentes.

Esta questão nos remete, por sua vez, à questão antropológica já clássica da eficácia do médico, portanto da relação médico-paciente, por contraste com a ambicionada eficácia da medicina. Em qualquer sistema médico, independentemente de sua racionalidade, grande parte de sua eficácia está condicionada ao desempenho do terapeuta. Este desempenho, por sua vez, está na dependência direta da relação que se estabelece entre ele e seu(s) paciente(s). O elemento simbólico, irredutível à racionalidade do sistema (a relação terapêutica) é que determina, em grande parte, a eficácia dos sistemas médicos complexos. A *ars curandi* sustenta, deste ponto de vista, a *scientia morborum*, e não o contrário, como pretende a ciência médica dos últimos cento e cinquenta anos.

Mas não há arte de curar desprovida de artefatos. O artefato por excelência da medicina ocidental (inclusive da homeopatia) é o remédio. O remédio torna-se, desta forma, o ponto fundamental de avaliação do desempenho do médico pelos doentes. Se o remédio "for bom", se "funcionar", o médico é bom; se não funcionar dentro de um certo prazo (brevíssimo no caso da biomedicina, mais "lento", no caso da homeopatia), o médico não é bom, pois "erra". Esta avaliação sobressai nas entrevistas realizadas com médicos da medicina ocidental contemporânea e da homeopatia.

Seria, entretanto, inexato, reduzir o "arsenal terapêutico" da biomedicina ao medicamento. Atualmente os próprios exames diagnósticos funcionam, para os pacientes, como elemento terapêutico. Pois na realização de uma "bateria de exames" já há uma legitimação médica, portanto social, do seu estatuto de doente, e uma busca de solução para o seu problema de saúde. Deste ponto de vista, os pacientes avaliam muito mal os médicos que não pedem exames sofisticados para diagnosticar "seu mal". É como se o que eles têm não tivesse importância, não fosse digno de "exame". Conforme ilustram as entrevistas realizadas, os pacientes da biomedicina chegam aos ambulatórios de triagem com a demanda de um determinado tipo de exame, e com seu diagnóstico patológico "pronto". Esta demanda, entretanto, é fruto da interiorização da própria medicina no seu momento atual de desenvolvimento tecnológico, produzida tanto pelas instituições médicas quanto pela difusão médica realizada pela mídia e pela propaganda dos interesses industriais ligados à tecnologia médica. Nada mais oposto à proposta institucional de atendimento médico integralizante, simplificado, privilegiando a recuperação da saúde sobre a investigação da doença, num contexto de atendimento de massa, como é originalmente a proposta do sistema público de saúde brasileiro (Sistema Único de Saúde).

Entretanto, a própria implementação do S.U.S. obedeceu, e obedece ainda hoje, à lógica estruturante da racionalidade médica ocidental contemporânea, valorizando os profissionais médicos especializados, e os procedimentos tecnológicos mais sofisticados, em detrimento daqueles mais globais e menos especializados, mais "generalistas", implicando menos recursos diagnósticos e terapêuticos. Estabelece-se, desta forma, uma aparente incongruência entre as exigências institucionais de funcionamento do sistema, e aquelas concernentes à racionalidade da biomedicina. As observações realizadas até o presente no contexto da pesquisa nos permitem afirmar a insatisfação dos profissionais, ou pelo menos sua frustração com um tipo de atendimento que facilita o abandono de tratamento pelos pacientes e que impede um estabelecimento consistente da relação médico-paciente.

A relação terapêutica, neste caso, se se pode falar da existência de uma relação do gênero neste caso, acaba se constituindo com a Instituição Médica (o posto de saúde, o hospital, o ambulatório), com a especialidade médica (a "pneumologia", a "ortopedia", a "gastro", etc), ou com um conjunto de serviços dispersos em várias instituições médicas. O paciente torna-se progressivamente um paciente abstrato, instituído por um circuito institucional de especialidades e procedimentos médicos, em geral diagnósticos. Por outro lado, a forma atual de organização dos serviços médicos reafirma a hegemonia deste tipo de racionalidade médica sobre as demais, menos dependentes de recursos tecnológicos e procedimentos sofisticados, desqualificando-as de algum modo como "pobres", "alternativas", atribuindo-lhes seu "lugar" e papel hierárquico no sistema de atenção à saúde da população. Assim, à medicina homeopática é atribuído o papel de tratar de doenças alérgicas, respiratórias, ou "psicossomáticas", ou ainda "crônicas", entendendo-se por esta expressão pacientes cronicamente circulantes no sistema sem alcançarem cura ou alívio para seu sofrimento, e à medicina tradicional chinesa cabe o papel de tratar de

doenças concernentes ao "aparelho músculo-esquelético", isto é, aqueles pacientes que sentem acima de tudo dor.

Esta atribuição de papéis terapêuticos a outras medicinas a partir da racionalidade da biomedicina dá origem a um conjunto de sincretismos conceituais e práticos nos distintos sistemas médicos presentes nos serviços de saúde. Isto pode ser observado desde a primeira etapa de observação empírica da pesquisa (julho-agosto de 1995), tanto na medicina homeopática quanto na medicina tradicional chinesa. Tais sincretismos, que combinam um imaginário mecânico do corpo e da saúde (típico da biomedicina), com representações sociais naturistas de "energia" ou força vital, típicas da cultura contemporânea, são comuns a médicos (ou terapeutas não médicos) e pacientes.

As representações sociais concernentes aos diversos sistemas médicos atuantes na cultura médica atual e nos serviços institucionais de saúde incluem não apenas os sincretismos mencionados, como outros, referentes a certas categorias como o tempo e a duração (de tratamentos ou procedimentos diagnóstico-terapêuticos), à intensidade (definida, no discurso dos pacientes, como "força" ou "profundidade" da ação dos procedimentos), ou à nocividade (capacidade de "prejudicar" ou não o organismo dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos). Os distintos procedimentos, assim como os sistemas médicos envolvidos, são então classificados, organizados e hierarquizados pela clientela de acordo com estas categorias, e procurados segundo os tipos de adoecimento e a gravidade a eles atribuída pelos pacientes. O que supõe uma operação de reinterpretação simbólica das categorias médicas (independentemente do sistema em questão) no seu próprio universo cultural, relativo à saúde e doença, que evidentemente não é um universo "tradicional", "popular" ou sintético, unitário (isto é, "fechado" como o de uma cultura moderna), mas sim um universo simbolicamente fragmentário e sincrético, atravessado por múltiplas representações, próprio de uma cultura urbana pós-moderna.

Através de combinações ou cruzamentos específicos desses critérios e categorias, os pacientes encaminham sua demanda a este ou aquele sistema médico, a este ou aquele serviço, escolhendo em que momento ou circunstância de seu adoecimento recorrerão preferencialmente a uns ou a outros. Em sua organização dos sistemas terapêuticos, que pode incluir inclusive a cura religiosa (ou "espiritual"), não há necessariamente oposição entre eles, mas atribuição de papéis e tarefas em função dos tipos e estágios de suas doenças.

Concluindo, os pacientes entrevistados na primeira e segunda etapas da segunda fase da pesquisa declararam-se geralmente "satisfeitos" com o tratamento que têm recebido nos três sistemas estudados. Mas a satisfação é mais com o serviço médico que com o médico, ou com a medicina, sobretudo no caso da biomedicina, em que a relação tradicional médico-paciente desaparece. Tudo se passa como se os pacientes encontrassem o que previamente foram buscar. No entanto, a satisfação com o tratamento deve ser tributada aos terapeutas e não à situação material e institucional dos serviços, muito criticada pela clientela e pelos próprios médicos. No interior dos serviços não foi observado conflito ou oposição aos programas de medicinas alternativas (homeopatia e medicina tradicional chinesa, através da acupuntura, das massagens terapêuticas e de exercícios de *Tai Chi Chuan*). Também não há indícios de comunicação institucional entre esses programas e os serviços tradicionais especializados de atendimento, salvo exceções (indicações da pediatria para a homeopatia, de artrose ou problemas neuro-musculares para a acupuntura, ou de "crônicos" para ambos). O que nos leva a pensar que no Brasil também, a exemplo do que vem sendo observado nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, e na própria tendência institucional internacional, através da O.M.S., essas medicinas estejam deixando de ser terapêuticas "alternativas" para se tornarem "complementares" à medicina ocidental contemporânea.

BIBLIOGRAFIA

- ALMEIDA FILHO, N. *Epidemiologia sem números*. Rio de Janeiro: Campus, 1989.
- ALMEIDA, E.L.V. *Medicina hospitalar - medicina extra - hospitalar: duas medicinas?* Rio de Janeiro: IMS/UERJ, 1988 (dissertação de mestrado).
- BACHELARD, G. *A epistemologia*. Lisboa: Edições 70, [1971].
- BACHELARD, G.L. *La formación del Espíritu Científico*. Mexico (D.F.): Siglo Vienturo, 1985, 13 ed.
- BALINT, M. *O médico, seu paciente e a doença* (trad. bras.). Rio de Janeiro: Ateneu, 1975.
- BONTEMPO, M. *Medicina Natural - medicina oriental*. São Paulo: Nova Cultural, 1992.
- BRODSKY, G. "Do Jardim do Éden à era de Aquário" in *O livro da cura natural*. 4. ed. São Paulo: Ed. Ground, 1987.
- CAMARGO Jr., K.R. "A Medicina Ocidental Contemporânea" in *Cadernos de Sociologia*, v. 7, Porto Alegre: Programa de Pós-Graduação em Sociologia, p. 129-150, dez. 1995.
- CAMARGO Jr., K.R. *As Ciências da AIDS e a AIDS das Ciências - O Discurso Médico e a Construção da AIDS*. Rio de Janeiro: Ed. ABIA/IMS/UERJ/Relume Dumará, 1994.

CAMARGO Jr., K.R. *Ir/Racionalidade Médica - Paradoxos da Clínica*, dissertação de Mestrado em Medicina Social, Rio de Janeiro: IMS/UERJ, 1991.

CANGUILHEM, G. "O que é uma ideologia científica?" in _____, *Ideologia e racionalidade nas ciências da vida*. Lisboa: Edições 70, 1977.

CANGUILHEM, G. *O normal e o patológico*. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1981.

CHAUVENNETT, A. A lei e o corpo (trad. port.). in *Physis*, v. 1, n. 1, p. 131-48. Rio de Janeiro: IMS/UERJ, Relume Dumará, 1991.

CHOPRA, D. *A cura quântica - o poder da mente e da consciência na busca da saúde integral*. São Paulo: Editora Best Seller, 1989.

CLAVREUL, J. *A Ordem Médica*, Rio de Janeiro: Ed. Brasiliense, 1983.

COULTER, H. *Divided Legacy - The schism in Medical Thought*. Berkeley, California: North Atlantic Books, 1982, 2ª edição, V. III.

DASH, V. B. *Fundamentals of Ayurvedic Medicine*. 7. ed. rev. New Delhi: Konark Publ. PVT, s.d.

DASH, V. B. & JUNIUS, A. M. M. *A handbook of Ayurveda*. 2. ed. New Delhi: Concept Publ. Co., 1987.

DEVARAJ, T. L. *Speaking of Ayurvedic remedies - for common diseases*. New Delhi: Sterling Publishers Private, 1985.

DEVARAJ, T. L. *The panchakarma treatment of Ayurveda*. 2. ed. Bangalore: Dhanvantari Oriental Publications, 1980.

EDDE, G. *La Medicine Ayur-vedique*. 2. ed. St. Jean-de-Braye: Ed. Dangles, 1985.

FAERSTEIN, E. "Ideologia, normas médicas e racionalidade epidemiológica: o caso do câncer genital feminino". Rio de Janeiro: Cad. IMS, 3(1):173-186 (1989), pg. 186.

FOUCAULT, M. *La arqueología del saber*. Mexico (D.F.): Siglo Veintiuno, 1972.

FOUCAULT, M. *Les Mots et Les Choses*. Paris: Ed. Gallimard, 1966.

FOUCAULT, M. *Microfísica do poder*. Rio de Janeiro: Graal, 1981.

FOUCAULT, M. *O Nascimento da Clínica*, (tradução brasileira), Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1978.

FRAWLEY, D. *Ayurvedic healing - a comprehensive guide*. Salt Lake City: Passage Press, 1989.

GINZBURG, C. *Mitos, Emblemas, Sinais* (trad. bras.). São Paulo: Cia. das Letras, 1989.

GONÇALVES, P. E. (Org.) *Medicinas alternativas: tratamentos não convencionais*. São Paulo: IBRASA, 1989.

HABERMAS, J. *Conhecimento e interesse*. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara, 1987.

HAHNEMANN, S. *Organon de la Medicina*. Nova Delhi: B. Jain Publishers, 1993. 6 ed., (ed. esp.).

HAWKING, S. W. *A brief history of time*. New York: Bantam Books, 1988.

HERMÓGENES, J. *Autoperfeição com Hatha Yoga*. 32. ed. Rio de Janeiro: Record, 1990.

HERZLICH, C. "A Problemática da Representação Social e sua Utilidade no Campo da Doença" (trad. port.) in *Physis*, v. 1, n. 2, Rio de Janeiro: IMS/UERJ/Relume Dumará, 1991, p. 23-34

JOHARI, H. *Chakras - centros energéticos de transformação*. 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1992.

KARAGULLA, S. & KUNZ, D. G. *Os chackras e os campos de energias humanos*. Trad. de Claudia Gerpe Duarte. São Paulo: Pensamento, 1989.

KENT, James. *Filosofia de La Homeopatia*. BA: Ed. El Ateneo, 1982. ed. esp.

KENT, James. *Lesser Writings*. Nova Delhi: B. Jain Publishers, 1976.

LAD, V. *Ayurveda - the science of self-healing*. 2. ed. Wilmot: Lotus Press, 1985.

LUZ, D. "A Medicina Tradicional Chinesa (MTC)": *Série Estudos em Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro: IMS/UERJ/CEPESC, n. 72, dez. 1993.

LUZ, H.S.; "Homeopatia e Racionalidade Médica" in *Revista da Associação Paulista de Homeopatia (APH)*, São Paulo: APH, v. 60, nºs 3 e 4, p. 3-13, 1995.

LUZ, M.T. "Racionalidades Médicas e Terapêuticas Alternativas": *Cadernos de Sociologia*, v. 7, Porto Alegre: Programa de Pós-Grad. em Sociologia, U.F.R.S., dez. 1995, p. 108, 128.

LUZ, M.T. *A Arte de curar e a ciência das doenças - história social da homeopatia no Brasil*. Livro em 7 capítulos, 345 p. Tese de Professor Titular em Saúde e Sociedade, Rio de Janeiro: IMS/UERJ, 1995 - Ed. Dynamis/ABRASCO, no prelo.

LUZ, M.T. *Natural, Racional, Social, Razão Médica e Racionalidade Científica Moderna*. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1988.

LUZ, M.T. et cols. *I Seminário do Projeto Racionalidades Médicas*, Rio de Janeiro: IMS/UERJ, julho/1992, 108 p.

LUZ, M.T. et cols. *II Seminário do Projeto Racionalidades Médicas*, Rio de Janeiro: IMS/UERJ, dezembro/1992, 74 p.

LUZ, M.T. et cols. *III Seminário do Projeto Racionalidades Médicas*, Rio de Janeiro: IMS/UERJ, agosto/1993, 168 p.

LUZ, M.T. et cols. *IV Seminário do Projeto Racionalidades Médicas*, Rio de Janeiro: IMS/UERJ, dezembro/1994, 52 p.

LUZ, M.T. et cols. *V Seminário do Projeto Racionalidades Médicas*, Rio de Janeiro: IMS/UERJ, dezembro/1995, 82 p.

MACHADO, R. *Ciência e saber*. Rio de Janeiro: Graal, 1982.

MARKERT, C. Yin e Yang - Polaridade e Harmonia em Nossa Vida. São Paulo: Ed. Cultrix, 1983.

NEEDHAM, J. *De la ciência y la tecnologia chinas*. Mexico: Ed. Siglo Vientiuno, 1978.

PAGE, M. *CH'I - Energia Vital* (trad. bras.). São Paulo: Ed. Pensamento, 1991.

POITEVIN, B. *Le devenir de l'Homeopathie (Éléments de Theorie et de Recherche)*. Paris: Ed. Doin, 1987.

PRIGOGINE, I. e STENGERS, I. *A nova aliança*. Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 1984.

QUEIROZ, M. *Representações sobre saúde e doenças. Agentes de Cura e Pacientes no Contexto do SUDS*. Campinas: Ed. UNICAMP, 1991.

ROCCA, J.J. e VERNON, P. *Guide pratique des medecines naturelles en France*. Paris: JJRC, 1984.

RODRIGUES, R. D. *A crise da medicina: prática e saber*. Rio de Janeiro: IMS, 1979.

ROSSI, P. *A Ciência e a Filosofia dos Modernos*. São Paulo: Ed. UNESP, 1992.

STENGERS, I. *Quem tem medo da ciência?* São Paulo: Ed. Siciliano, 1991.

TAMAYO, R.P. *El concepto de enfermedad*, UNAM, México, DF: Ed. Fondo de Cultura Econômica, 1988, II volumes, V. I.

UNSCHULD, P. *Medicine in China - A history of Ideas*. L.A. London: University of California Press, Berkeley, 1985.

VANNIER, P. *La Homeopatia*. B.A.: Ed. Lidim, (trad. esp.), 1985.

VIJNOVSKY, B. *Traduccion y Comentareos del Organon de Hahnemann*. B.A.: Ed. Lidim, 1985.

VITHOUKAS, G. *La Science de l'homéopathie*. Monaco: Ed. Rocher, 1980.

WEBER, Max. *A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo* (trad. bras.). São Paulo: Pioneira Ed., 1967.

ZIMMER, H. *Mitos e símbolos na arte e civilização da Índia*. Compilado por Joseph Campbell. São Paulo: Palas Athena, 1989.

**SÉRIE: ESTUDOS EM SAÚDE COLETIVA
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE TEXTOS**

1. APRESENTAÇÃO DE TEXTOS

Os textos, quando entregues ao Depto. de Publicações do Instituto de Medicina Social da UERJ, devem atender às seguintes exigências:

- a) estar escritos na língua portuguesa e tratar de temas ligados, preferencialmente, à saúde e políticas públicas e sociais;
- b) ser apresentados em disquetes 3½, acompanhados de 3 (três) cópias em papel, tendo sido digitados em *Word for Windows*;
- c) constar de no mínimo 20 e no máximo 70 laudas (30 linhas com 70 toques por linha); casos excepcionais serão julgados pela Editoria da Série;
- d) estar acompanhados de resumos em português e em inglês, com 100 a 200 palavras cada, e apresentarem um mínimo de três palavras-chave descritoras do conteúdo, também em português e em inglês;
- e) estar acompanhados de apresentação dos autores (qualificação profissional e vínculos institucionais);
- f) as NOTAS deverão ser apresentadas no pé das páginas e as REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS deverão ser apresentadas ao final do artigo, em páginas específicas destinadas a este fim;
- g) as NOTAS deverão ser numeradas consecutivamente, em algarismos arábicos;
- h) os GRÁFICOS e TABELAS deverão ser numerados consecutivamente, em algarismos romanos;
- i) poderão ser feitas citações no texto, somente indicando o último sobrenome do autor citado, o ano de publicação e página (quando for o caso), entre parênteses. Ex.: (Litton, 1983, p.75);
- j) as REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS devem ter as indicações necessárias à perfeita identificação das obras, de acordo com as normas da ABNT. Exemplos:

Para livros

DIAS, Gonçalves. *Gonçalves Dias: poesia*. Organizada por Manuel Bandeira; revisão crítica por Maximiano de Carvalho e Silva. 11 ed. Rio de Janeiro: Agir, 1983. 87 p. (Nossos Clássicos, 18)

Para artigos

MOURA, Alexandrina Sobreira de. Direito de habitação às classes de baixa renda. *Ciência e Trópico*, Recife, v. 11, n.1, p. 71-78, jan./jun. 1983.

Para capítulos de livros

LAYTON, E. Conditions of technological development. In: SPIEGEL, Ina, PRICE, Derek de Solla. *Science, technology and society; a cross-disciplinary perspective*. California, Sage, 1977. p. 197-222.

Para trabalhos publicados em Anais

CORDEIRO, Rosa Inês de N. Descrição e representação de fotografias de cenas e fotogramas de filmes: um esquema de indexação. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 16. 1991. *Anais...* Salvador: APBEB, 1991. v. 2, p. 1008-1022.

2. INDICAÇÃO E PARECER EDITORIAL

- a) os textos, quando de autoria de alunos, deverão estar acompanhados de indicação para publicação, por escrito, emitida por professor do IMS;
- b) todos os textos apresentados para publicação serão submetidos a parecer de pelo menos um membro do Conselho Editorial ou de consultor que a Editoria da Série considere oportuno convidar, de acordo com suas especificidades. A indicação apontada no item 2.a) não exclui a emissão do parecer aqui referido.

3. REVISÃO E AJUSTES DOS TEXTOS

- a) nos casos de aprovação com ressalvas, os textos serão devolvidos aos autores para revisão e alteração, a serem realizadas no prazo máximo de 10 (dez) dias;
- b) após aprovação para publicação, os textos serão submetidos a profissional qualificado para dar procedimento ao copidesque, que deverá ser revisto pelos autores no prazo máximo de 5 (cinco) dias;
- c) os textos alterados ou revisados, devolvidos pelos autores em prazos superiores aos determinados nos itens 3.a) e 3.b), serão publicados de acordo com novo cronograma de produção a ser definido pela Editoria da Série.

4. PRIORIDADE

Será prioritária a publicação de textos de autoria de professores e alunos do Instituto de Medicina Social da UERJ.

5. EXEMPLARES PARA OS AUTORES

Os autores terão direito a 10 (dez) exemplares gratuitos dos números da Série em que constem seus textos.

6. CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão analisados pelo Editor da Série.